Клинические рекомендации

Бронхиальная астма

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J45** — Астма **J45.0** — Астма с преобладанием аллергического компонента **J45.1** — Неаллергическая астма **J45.8** — Смешанная астма **J45.9** — Астма неуточненная **J46** — Астматическое статус (status asthmaticus) **Z57.2** — Неблагоприятное воздействие производственной пыли **Z57.3** — Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха **Z57.4** — Неблагоприятное воздействие токсичных веществ, используемых в сельском хозяйстве **Z57.5** — Неблагоприятное воздействие токсичных веществ в других производствах
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 15.11.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Ассоциация врачей и специалистов медицины труда; Российское респираторное общество
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/359_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **3**

2. Клиническая картина и классификация **3**

2.1 Определение 3

2.2 Классификация 3

2.3 Клиническая картина 4

3. Диагностика **4**

3.1 Жалобы и анамнез 4

3.2 Физикальное обследование 4

3.3 Лабораторные исследования 5

3.4 Спирометрия и бронходилатационный тест 5

3.5 Пикфлоуметрия 5

3.6 Оксид азота в выдыхаемом воздухе (FeNO) 5

3.7 Аллергологическое обследование 5

3.8 Дифференциальная диагностика 5

4. Лечение **6**

4.1 Лёгкая бронхиальная астма 6
4.2 Тяжёлая бронхиальная астма 6
4.3 Обострение 6
4.4 Аллерген-специфическая иммунотерапия 6
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 6
5.1 Профилактика 6
5.2 Диспансерное наблюдение 7
5.3 Показания к госпитализации 7
6. Источник и актуальность 7
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 7

1. Основные положения

- Бронхиальная астма — гетерогенное заболевание с хроническим воспалением дыхательных путей, респираторными симптомами, вариабельными по времени и интенсивности, и вариабельной обструкцией дыхательных путей.
- Обострение риносинусита относится к факторам, способным привести к обострению БА; риносинусит — к сопутствующим заболеваниям, повышающим риск обострений. При аллергическом рините или полипозном риносинусите пациент с БА направляется к оториноларингологу.
- Обструкцию и её обратимость подтверждают спирометрией с бронходилатационным тестом пациентам **старше 5 лет**: тест положителен при приросте ОФВ1 **не менее 12% и не менее 200 мл**.
- Лечение ступенчатое, по уровню контроля и факторам риска обострений. При лёгкой БА у пациентов **старше 12 лет** предпочтителен будесонид + формотерол по потребности; монотерапия КДБА по потребности больше не рекомендуется.
- Госпитализация показана при недостаточной эффективности амбулаторной терапии, в том числе при обострении, и при тяжёлом и/или угрожающем жизни обострении с признаками дыхательной недостаточности.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Бронхиальная астма (БА) — гетерогенное заболевание, характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов (приступы затруднения дыхания, удушья, свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель), которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей.

2.2 Классификация

Фенотипы бронхиальной астмы

1. **аллергическая (атопическая)** — начинается, как правило, в детстве, связана с другими аллергическими болезнями (атопический дерматит, аллергический ринит, пищевая аллергия) у пациента или родственников; эозинофильное воспаление и хороший ответ на ИГКС; является показанием для АСИТ
2. **неаллергическая** — в том числе «аспирин-чувствительная» и профессиональная; встречается преимущественно у взрослых, не связана с аллергией; ответ на ИГКС может быть недостаточным
3. **с поздним дебютом** — чаще у женщин, дебют во взрослом возрасте, чаще без аллергии
4. **с фиксированной обструкцией дыхательных путей** — при длительном анамнезе, вследствие ремоделирования бронхиальной стенки
5. **у пациентов с ожирением** — выраженные респираторные симптомы, не связанные с эозинофильным воспалением

Степень тяжести — по объёму терапии, необходимому для контроля

1. **лёгкая** — хорошо контролируется терапией 1 или 2 ступени
2. **среднетяжёлая** — хорошо контролируется терапией 3 или 4 ступени
3. **тяжёлая** — для контроля требуется терапия 5 ступени; попытки снизить объём неизменно приводят к потере контроля, или астма остаётся неконтролируемой несмотря на лечение

2.3 Клиническая картина

Одышка при БА преимущественно экспираторная. Симптомы вариабельны по времени и интенсивности, часто ухудшаются ночью или рано утром.

Аускультативно — удлинение выдоха и сухие высокотональные хрипы над всей поверхностью грудной клетки, обычно дистанционные.

Основные триггеры обострения

1. инфекции респираторного тракта (в основном вирусы, чаще всего риновирусы);
2. аллергены, аэрополлютанты;
3. физическая нагрузка, метеорологические факторы;
4. некоторые лекарственные препараты: бета-адреноблокаторы, а при индуцированном ацетилсалициловой кислотой и НПВП респираторном заболевании («аспириновая БА») — НПВП;
5. эмоциональные реакции.

К обострению БА способны также привести обострение риносинусита, гастроэзофагеальный рефлюкс, беременность и недостаточная терапия.

Факторы риска обострений

1. симптомы неконтролируемой БА;
2. ИГКС не назначены, плохая приверженность терапии;
3. чрезмерное использование КДБА;
4. низкий ОФВ1, особенно **менее 60% от должного**;
5. курение, воздействие аллергена;
6. сопутствующие заболевания: риносинусит, ГЭРБ, подтверждённая пищевая аллергия, ожирение;
7. эозинофилия мокроты или крови;
8. беременность;
9. одно и более тяжёлых обострений **за последние 12 месяцев**.

---

3. Диагностика

3.1 Жалобы и анамнез

Анамнез и жалобы собирают при болезнях верхних дыхательных путей и при заболеваниях лёгких и бронхов — для подтверждения диагноза, оценки тяжести и выявления факторов, влияющих на выбор лечения.

Уточняют причины возникновения, продолжительность и разрешение симптомов, наличие аллергических заболеваний (атопический дерматит, аллергический ринит, пищевая аллергия) у пациента и кровных родственников. Важный клинический маркер БА — исчезновение симптомов спонтанно или после лекарственной терапии.

3.2 Физикальное обследование

Оценивают общее состояние, выполняется визуальное исследование верхних дыхательных путей, осмотр и аускультация.

При осмотре можно выявить признаки аллергического ринита или полипоза носа: затруднение носового дыхания, приоткрытый рот.

Одышка, выявленная при осмотре, может быть обусловлена

1. обструкцией на уровне верхних дыхательных путей;
2. ХОБЛ, преимущественно у взрослых;
3. у детей — респираторной инфекцией, трахеомаляцией, аспирацией инородного тела.

3.3 Лабораторные исследования

Уровень иммуноглобулинов A, M, G в крови исследуется для выявления нарушений гуморального звена иммунитета у пациентов с БА, часто страдающих повторными бактериальными инфекциями верхних и нижних дыхательных путей:

1. гнойные риносинуситы;
2. отиты;
3. бронхиты, пневмонии.

3.4 Спирометрия и бронходилатационный тест

Показания

1. установление диагноза БА у пациентов **старше 5 лет**;
2. контроль через **2–4 недели** после назначения терапии;
3. диспансерное наблюдение — **каждые 6–12 месяцев**;
4. перед назначением ГИБП и перед АСИТ.

Диагностические признаки

1. обструкция: ОФВ1/ФЖЕЛ **менее 70%**;
2. степень тяжести обструкции оценивают по отклонению ОФВ1 от должных величин.

Бронходилатационный тест выполняется всем пациентам **старше 5 лет** при установлении диагноза, включая пациентов с нормальной исходной спирометрией, — для выявления обратимости обструкции.

Тест положителен при приросте ОФВ1 **не менее 12% и не менее 200 мл** от исходного значения; повторная спирометрия — через **15 минут** после КДБА.

3.5 Пикфлоуметрия

Выполняется пациентам **старше 5 лет**, если спирометрия невозможна, — для подтверждения вариабельности воздушного потока; при диспансерном наблюдении — для оценки контроля и рисков обострения.

Диагноз подтверждает средняя суточная вариабельность ПСВ **более 13% у детей** и **более 20% у взрослых**, а также прирост ПСВ **не менее 15%** после бронхолитика или пробного назначения ИГКС.

3.6 Оксид азота в выдыхаемом воздухе (FeNO)

Определяется пациентам **старше 5 лет** при установлении диагноза и фенотипа — для выявления эозинофильного воспаления. FeNO **более 20–25 ppb** наряду с эозинофилией мокроты и крови — биомаркер активного эозинофильного воспаления; повышенный уровень связан с хорошим ответом на ИГКС.

3.7 Аллергологическое обследование

Кожные тесты с аллергенами выполняются пациентам **старше 5 лет** без противопоказаний — для подтверждения аллергического фенотипа, выявления причинно-значимых аллергенов и решения о целесообразности АСИТ.

3.8 Дифференциальная диагностика

У детей младше 5 лет — в том числе

1. рецидивирующие респираторные инфекции, коклюш;
2. аспирация инородного тела;
3. врождённые структурные аномалии (трахеомаляция и др.);
4. первичная цилиарная дискинезия, первичный иммунодефицит;
5. ларингеальная дисфункция.

У детей старше 6 лет также — индуцированная ларингеальная обструкция, дисфункциональное дыхание, ЭГПА; у взрослых — ХОБЛ, АБЛА, центральная обструкция дыхательных путей, кашель на фоне ингибиторов АПФ.

4. Лечение

Лечение ступенчатое: объём терапии корректируют по уровню контроля и наличию факторов риска обострений. Объём увеличивают, если БА остаётся неконтролируемой при хорошей приверженности и правильной технике ингаляции.

Объём снижают при стабильном контроле **более 3 месяцев** и отсутствии факторов риска; дозу ИГКС снижают медленно, **каждые 3 месяца на 25–50%**.

4.1 Лёгкая бронхиальная астма

Пациентам с лёгкой БА **старше 12 лет** предпочтителен будесонид + формотерол по потребности — для снятия симптомов и приступов удушья, с быстрым бронхолитическим и противовоспалительным действием.

1. будесонид + формотерол, ДПИ 160/4,5 мкг, взрослые и подростки от 12 лет: по 1–2 ингаляции по потребности, желательно не более 6 в сутки, максимум 12 ингаляций в сутки

На 1–2 ступенях монотерапия КДБА по потребности при лёгкой БА больше не рекомендуется.

4.2 Тяжёлая бронхиальная астма

Пациентам **с 6 лет** с тяжёлой БА рассматривают генно-инженерные биологические препараты с учётом фенотипа — в дополнение к базисной терапии. Решение о назначении и выборе ГИБП принимает врачебный консилиум.

Среди критериев отбора для биологической терапии Т2-астмы — сопутствующие заболевания, например рецидивирующий полипозный риносинусит и атопический дерматит.

Дупилумаб, помимо тяжёлой БА с Т2-воспалением, одобрен для терапии хронического полипозного риносинусита, тяжёлого атопического дерматита и эозинофильного эзофагита, что позволяет достигать контроля сопутствующих заболеваний с Т2-воспалением.

4.3 Обострение

Препараты первой линии при обострении — КДБА и антихолинергические средства ингаляционно, ИГКС (предпочтительно через небулайзер), системные глюкокортикостероиды и оксигенотерапия.

При среднетяжёлом и тяжёлом обострении рассматривают системные глюкокортикостероиды.

При обострении на фоне бактериальной инфекции (бронхит, пневмония, бактериальный риносинусит) рассматривают системные антибактериальные препараты.

Рутинное применение антибиотиков при обострении БА не рекомендуется — только при чётких указаниях на бактериальную инфекцию.

4.4 Аллерген-специфическая иммунотерапия

АСИТ (сублингвальная или подкожная) проводится пациентам с контролируемой атопической БА при доказанной клинически значимой сенсибилизации и отсутствии противопоказаний.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Всем пациентам с аллергическим ринитом рассматривают целесообразность АСИТ — для профилактики развития БА.

5.2 Диспансерное наблюдение

Диспансерное наблюдение аллерголога-иммунолога или пульмонолога, а также терапевта, педиатра или врача общей практики — **не реже 1 раза в год** для взрослых и **не реже 2 раз в год** для детей.

При необходимости пациент направляется на диспансерный приём оториноларинголога — при сопутствующих заболеваниях, например аллергическом рините или полипозном риносинусите.

5.3 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. диагностика БА и дифференциальная диагностика, бронхоконстрикторные тесты, подбор терапии;
2. недостаточная эффективность амбулаторной терапии, в том числе при обострении: нет ответа на лечение или прогрессивное ухудшение симптомов **в течение часа** от начальной терапии;
3. тяжёлое и/или угрожающее жизни обострение с признаками дыхательной недостаточности;
4. плановая терапия ГИБП;
5. ускоренный курс АСИТ в условиях элиминации аллергена.

Критерии выписки

1. достигнут контроль или частичный контроль над симптомами;
2. ПСВ и ОФВ1 **более 80%** от индивидуального лучшего или расчётного показателя;
3. нет признаков острой дыхательной недостаточности;
4. завершены наблюдение после введения ГИБП или курс АСИТ.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Бронхиальная астма»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 15.11.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2027 года
Код в рубрикаторе	359_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Ассоциация врачей и специалистов медицины труда; Российское респираторное общество
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых противоречий в тексте рекомендации при сверке не выявлено.